

ID	Participante	Área	Fragmento / evidencia	Código	Nombre del código	Categoría preliminar	Interpretación analítica	Necesidad o requisito derivado	Tipo	Prioridad
1	P01	Psicología	Actualmente utilizo Excel para registrar el agendamiento.	C01	Agendamiento en hoja de cálculo	Gestión de citas	El proceso depende de una herramienta no especializada y de actualización manual.	Implementar agenda digital centralizada con disponibilidad por profesional.	Problema	Alta
2	P01	Psicología	Cuando el paciente es frecuente, le escribo para reagendar; si no tengo contacto, espero que regrese.	C02	Reagendamiento informal	Gestión de citas	La reprogramación depende del contacto personal y no existe trazabilidad automática.	Permitir cancelar, reagendar y notificar citas desde el sistema.	Problema	Alta
3	P01	Psicología	La historia clínica se maneja de forma física y queda bajo custodia de enfermería.	C03	Historia clínica física	Historia clínica	La atención depende de expedientes físicos almacenados en un único punto.	Digitalizar y centralizar la historia clínica con acceso por rol.	Problema	Alta
4	P01	Psicología	A veces se traspapela el documento o simplemente no lo encuentran.	C04	Pérdida o extravío de expedientes	Historia clínica	El soporte físico ocasiona pérdida temporal de información y retrasos.	Incorporar búsqueda por cédula, respaldo y control de versiones.	Problema	Alta
5	P01	Psicología	Si fuera digital sería mucho más rápido; uno podría buscar y ya.	C05	Necesidad de búsqueda rápida	Transformación digital	Se requiere acceso inmediato y directo a la información clínica.	Crear buscador por cédula, nombre y número de historia clínica.	Necesidad	Alta
6	P01	Psicología	Se deben registrar datos personales, antecedentes, enfermedades y comportamiento.	C06	Datos clínicos específicos por especialidad	Historia clínica	Cada área necesita campos generales y campos especializados.	Configurar secciones clínicas específicas para psicología.	Necesidad	Media
7	P02	Medicina General	Se atiende por orden de llegada y según la clasificación del Triage de Manchester.	C07	Priorización por triaje	Atención clínica	La secuencia de atención debe considerar prioridad clínica y no solo llegada.	Registrar nivel de prioridad y ordenar automáticamente la atención.	Proceso actual	Alta
8	P02	Medicina General	El tiempo definido de atención es de veinte minutos.	C08	Duración estándar de consulta	Gestión de citas	La agenda debe considerar una duración predeterminada por servicio.	Configurar duración de citas por especialidad o tipo de atención.	Regla de negocio	Media
9	P02	Medicina General	Si necesito una interconsulta, voy directamente a preguntar al otro servicio.	C09	Coordinación presencial entre áreas	Comunicación interáreas	La interconsulta depende de comunicación verbal y desplazamiento físico.	Crear derivaciones e interconsultas digitales con estado y respuesta.	Problema	Alta
10	P02	Medicina General	La información se registra en una hoja de ruta con diagnóstico y hora.	C10	Registro clínico en hoja de ruta	Historia clínica	Existe duplicación de registros y falta de integración con la historia clínica.	Integrar atención, diagnóstico y hora en un único registro clínico.	Problema	Alta
11	P02	Medicina General	Siempre tengo inconvenientes para encontrar el historial.	C11	Dificultad recurrente de localización	Historia clínica	La búsqueda manual afecta de manera permanente la atención.	Implementar índice digital, filtros y consulta inmediata.	Problema	Alta
12	P02	Medicina General	Los antecedentes personales, familiares y la medicación previa son imprescindibles.	C12	Antecedentes y medicación previa	Historia clínica	El profesional necesita información longitudinal para tomar decisiones.	Registrar antecedentes, alergias y tratamientos previos estructurados.	Necesidad	Alta
13	P02	Medicina General	Los historiales están en un archivador; solo el personal accede, pero no significa que estén seguros.	C13	Confidencialidad física insuficiente	Seguridad y privacidad	El acceso está limitado, pero no existe control técnico ni auditoría.	Aplicar autenticación, roles, permisos y bitácora de acceso.	Riesgo	Alta
14	P02	Medicina General	El inventario se controla en una hoja de Excel.	C14	Inventario en Excel	Medicamentos e inventario	El stock se administra por separado y manualmente.	Implementar inventario integrado con entradas, salidas y existencias.	Problema	Alta
15	P02	Medicina General	A veces los medicamentos se agotan sin reposición anticipada.	C15	Desabastecimiento ocasional	Medicamentos e inventario	No existen alertas oportunas de stock mínimo.	Generar alertas de stock mínimo y vencimiento.	Problema	Alta
16	P02	Medicina General	En la hoja no se registra qué medicamento recibió; hay que buscar la receta.	C16	Trazabilidad incompleta de entrega	Medicamentos e inventario	La dispensación no está vinculada completamente al paciente.	Relacionar receta, detalle, medicamento, cantidad y entrega.	Problema	Alta
17	P02	Medicina General	No existe un medio formal; a veces se informa por redes sociales.	C17	Comunicación no formal con pacientes	Notificaciones	Los cambios de servicio no se comunican de forma sistemática.	Enviar notificaciones de horarios, cancelaciones y disponibilidad.	Problema	Alta
18	P02	Medicina General	Los usuarios llegan sin saber que no habrá atención con bastante frecuencia.	C18	Paciente desinformado sobre disponibilidad	Notificaciones	La falta de avisos genera viajes innecesarios y mala experiencia.	Notificar ausencias y cambios antes de la cita.	Problema	Alta
19	P02	Medicina General	El sistema debe ser específico y no complicado de manejar.	C19	Usabilidad y simplicidad	Adopción tecnológica	La aceptación depende de una interfaz sencilla y de pocos pasos.	Diseñar interfaz intuitiva, lenguaje claro y flujo breve.	Requisito no funcional	Alta
20	P03	Terapia Física	Trabajamos mediante agendamiento y tenemos alta demanda de pacientes.	C20	Alta demanda con agenda limitada	Gestión de citas	La capacidad disponible condiciona el acceso al servicio.	Mostrar cupos, lista de espera y próxima disponibilidad.	Problema	Alta
21	P03	Terapia Física	Se espera quince minutos; después no se atiende para no afectar al siguiente turno.	C21	Tolerancia de llegada	Gestión de citas	Existe una regla temporal específica del área.	Configurar tolerancia y marcar inasistencia automáticamente.	Regla de negocio	Media
22	P03	Terapia Física	En cada sesión se debe anotar cómo va evolucionando el paciente.	C22	Registro periódico de evolución	Seguimiento clínico	El tratamiento requiere notas longitudinales por sesión.	Permitir notas de evolución fechadas y asociadas al profesional.	Necesidad	Alta
23	P03	Terapia Física	Las hojas pueden confundirse con expedientes de otras áreas.	C23	Confusión entre expedientes	Historia clínica	La organización física provoca errores de identificación y archivo.	Centralizar expediente único con separación por especialidad.	Problema	Alta

24	P03	Terapia Física	Trabajamos de manera multidisciplinaria y derivamos a nutrición.	C24	Trabajo multidisciplinario	Comunicación interáreas	La atención requiere compartir información entre especialidades.	Crear derivaciones con motivo, destino, prioridad y seguimiento.	Proceso actual	Alta
25	P03	Terapia Física	Algunas personas mayores necesitarían capacitación para usar tecnología.	C25	Necesidad de capacitación	Adopción tecnológica	La edad y experiencia digital pueden afectar la adopción.	Incluir capacitación, ayuda contextual y manual de usuario.	Riesgo	Media
26	P04	Nutrición	Los controles son mensuales o cada quince días según la enfermedad.	C26	Periodicidad variable de controles	Seguimiento clínico	La frecuencia depende del diagnóstico y evolución del paciente.	Programar controles recurrentes configurables.	Regla de negocio	Media
27	P04	Nutrición	Tenemos historias clínicas físicas y una base de datos en Drive.	C27	Información distribuida en varios medios	Historia clínica	Los datos están fragmentados entre papel y almacenamiento en la nube.	Unificar registros clínicos, agenda e informes en una sola plataforma.	Problema	Alta
28	P04	Nutrición	Se tarda mucho llenando nuevamente los datos del paciente.	C28	Duplicación de captura de datos	Historia clínica	Los mismos datos se registran varias veces por diferentes profesionales.	Reutilizar datos generales y permitir completar solo datos especializados.	Problema	Alta
29	P04	Nutrición	El plan alimentario se envía por WhatsApp y se guarda en un pendrive.	C29	Planes alimentarios fuera del sistema	Seguimiento clínico	Los documentos terapéuticos no quedan integrados al expediente.	Adjuntar y enviar planes alimentarios desde la historia clínica.	Problema	Media
30	P04	Nutrición	Necesito peso, talla, IMC, circunferencias, grasa corporal y masa muscular.	C30	Indicadores antropométricos	Seguimiento clínico	El área requiere variables especializadas y comparación histórica.	Crear módulo nutricional con indicadores y gráficos de evolución.	Necesidad	Alta
31	P04	Nutrición	Sería útil ver exámenes, diagnóstico y cómo varía la glucosa.	C31	Seguimiento de parámetros clínicos	Seguimiento clínico	Se necesita comparar resultados en diferentes controles.	Registrar valores por fecha y mostrar tendencia histórica.	Necesidad	Alta
32	P05	Odontología	Si no tienen cita, se atienden según el orden de llegada.	C32	Atención mixta con y sin cita	Gestión de citas	El área combina agendamiento con atención espontánea.	Gestionar turnos programados y demanda espontánea.	Regla de negocio	Alta
33	P05	Odontología	A veces no se puede atender por falta de insumos odontológicos.	C33	Falta de insumos	Recursos e inventario	La disponibilidad de insumos condiciona la prestación del servicio.	Controlar insumos por área y alertar faltantes.	Problema	Alta
34	P05	Odontología	A veces se pierden las fichas y buscarlas tarda entre diez y quince minutos.	C34	Tiempo de búsqueda elevado	Historia clínica	La búsqueda manual consume tiempo clínico.	Digitalizar expedientes y habilitar búsqueda inmediata.	Problema	Alta
35	P05	Odontología	El historial debería detallar enfermedades, medicamentos y alergias.	C35	Historia clínica insuficientemente detallada	Historia clínica	Los campos actuales no apoyan completamente la prescripción segura.	Añadir alergias, contraindicaciones y medicación actual.	Necesidad	Alta
36	P05	Odontología	Google Drive guarda información de pacientes, pero falta una historia clínica digital completa.	C36	Herramienta parcial no especializada	Transformación digital	La herramienta actual no cubre flujos clínicos ni trazabilidad.	Implementar sistema especializado y migrar información pertinente.	Problema	Alta
37	P05	Odontología	Sería útil enviar la receta digital directamente a enfermería.	C37	Receta digital interáreas	Medicamentos e inventario	El papel ralentiza la dispensación y puede perderse.	Emitir receta electrónica y enviarla al área dispensadora.	Necesidad	Alta
38	P05	Odontología	Se necesitan reportes diarios o mensuales de atención.	C38	Reportes de atención	Reportes y control	La coordinación requiere consolidar actividad por periodos.	Generar reportes por área, profesional, diagnóstico y periodo.	Necesidad	Media
39	P06	Enfermería	La principal dificultad es que algunos representantes no conocen la cédula del menor.	C39	Datos de identificación incompletos	Registro de pacientes	La falta de datos confiables genera riesgo de duplicidad o error.	Validar identidad y permitir registro provisional controlado.	Problema	Alta
40	P06	Enfermería	Sería mejor ingresar el número y encontrar directamente el archivo.	C40	Búsqueda por cédula	Registro de pacientes	La cédula es el identificador principal esperado por el usuario.	Implementar búsqueda exacta y validación de duplicados por cédula.	Necesidad	Alta
41	P06	Enfermería	La información debería reflejarse en la computadora de las otras áreas.	C41	Interoperabilidad interna	Comunicación interáreas	Se requiere disponibilidad inmediata de datos entre profesionales autorizados.	Sincronizar historia clínica y derivaciones en tiempo real.	Necesidad	Alta
42	P06	Enfermería	El informe incluye nombre, gramos, fecha de fabricación y vencimiento.	C42	Control de lote y vencimiento	Medicamentos e inventario	El inventario necesita atributos de trazabilidad del producto.	Registrar lote, presentación, fabricación, vencimiento y cantidad.	Necesidad	Alta
43	P06	Enfermería	No habría dificultades para implementar el sistema porque hay equipos e Internet.	C43	Infraestructura disponible	Adopción tecnológica	Existen condiciones técnicas favorables para la implementación.	Priorizar capacitación y migración más que adquisición de infraestructura.	Facilitador	Media
44	P07	Recepción	Primero pasa por recaudación, luego por enfermería y después al área correspondiente.	C44	Flujo secuencial de atención	Admisión y recepción	La atención sigue etapas definidas que deben registrarse.	Modelar estados: registrado, pagado, triaje y en atención.	Proceso actual	Alta
45	P07	Recepción	Se solicita la copia de cédula y datos personales.	C45	Registro administrativo inicial	Registro de pacientes	Recepción captura la identidad antes del flujo clínico.	Crear admisión con datos personales y validación documental.	Proceso actual	Alta
46	P07	Recepción	Las citas se manejan por turno; algunas áreas sí agendan.	C46	Gestión heterogénea de turnos	Gestión de citas	Cada especialidad utiliza reglas distintas.	Configurar modalidad de atención por área.	Problema	Alta
47	P07	Recepción	Para reagendar, el paciente debe acercarse al profesional.	C47	Reagendamento presencial	Gestión de citas	La reprogramación exige desplazamiento y depende de cada área.	Permitir reagendamento centralizado y comunicación automática.	Problema	Alta

48	P07	Recepción	La orientación y recaudación son actividades forzosas y manuales.	C48	Carga administrativa manual	Admisión y recepción	La recepción invierte tiempo en tareas repetitivas.	Automatizar registro, cobro, emisión de turno y derivación.	Problema	Alta
49	P07	Recepción	El sistema debería registrar al paciente y dirigirlo al área correspondiente.	C49	Derivación administrativa automatizada	Admisión y recepción	El sistema debe apoyar la orientación inicial.	Asignar área y profesional según servicio seleccionado.	Necesidad	Alta